



認識上心室頻脈

心跳突然變快、又突然停止 —— 問題出在心室「上面」的電路

多數不會立即危及生命，而且電燒常可根治



掃描看電子版

① 什麼是上心室頻脈？



心跳可以衝到 150~250 下 / 分
常常**突然開始、突然結束**，可能幾秒到幾小時，也可能自己停下來。

常見的四種型態

AVNRT 房室結迴旋

訊號在房室結附近繞圈（最常見）

AVRT 房室迴旋

多一條「旁路」連接心房與心室

AT 心房性心搏過速

心房某一處異常快速放電

另有AFL 心房撲動：心房內大迴圈電路

② 常見症狀

每個人不一定相同；有些人只覺得「心臟在跳」



心悸
感覺心臟在跳



胸悶、胸痛
壓迫或悶悶的



喘
呼吸不順



頭暈
天旋地轉



無力、疲倦
做一點事就累



快昏倒、昏倒
要立刻處理

③ 常見誘發因素

任何年齡都可能發生；也可能完全找不到誘因



壓力、焦慮



咖啡因、能量飲



酒精



尼古丁



睡不夠、疲勞



發燒、脫水



部分感冒、氣喘藥

④ 有哪些治療？

依心律型態、症狀與個人風險，由醫病共同決定

藥物治療

發作當下：先做迷走神經刺激法，
無效時由醫護給腺苷等靜脈藥物
長期：乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑
等；可減少發作但不能根治
低血壓、休克、持續胸痛 → 立即電復律

電燒治療（導管電燒）

反覆且有症狀的 AVNRT、AVRT：
是指引建議的根治選項
成功率高，多數人術後不需吃心律藥
風險：出血 / 血腫、心包積液；少數
可能房室傳導阻滯而需裝節律器

⑤ 出現這些情況，就近醫療院所就醫或立即撥打 119

持續胸痛 | 嚴重呼吸困難 | 昏倒 | 冒冷汗或意識改變
術後：穿刺處持續出血或快速腫大 | 單側無力、口齒不清

提醒：不要自行停藥；抗凝血藥、心律藥與禁食時間，請依醫療團隊指示。

資料來源（查核至 2026-09）：

2019 ESC Guidelines for the Management of Patients with Supraventricular Tachycardia；

2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult Patients with Supraventricular Tachycardia。本單張供衛教，不取代個別診療。

© 2026 林祐騰醫師 編製 本單張僅供臨床衛教使用，未經同意請勿重製、改作或作商業用途。